

GIẢI PHẪU

Câu 1: Mô tả eo trên, nêu sự khác biệt giữa chậu hông nam và nữ, U'DLS.

1. Đại cương:

- Chậu hông là khung chậu được cấu tạo từ 2 xương chậu, xương cùng, xương cụt và các dây chằng liên kết giữa các khớp xương tạo lên.
- Chậu hông gồm có 2 phần:
 - + Ở trên là chậu hông lớn: gồm các thành phần thuộc ÔB: chủ yếu các tạng của hệ tiêu hoá.
 - + Ở dưới là chậu hông nhỏ: gồm các thành phần thuộc hệ SD-TN, một phần hệ tiêu hoá là trực tràng và ống hậu môn.
- Hai phần này được ngăn cách với nhau bởi eo trên
- Phần dưới thu hẹp lại là eo dưới.
- Chậu hông có ý nghĩa quan trọng trong y học, pháp y và nhân chủng học,...

2. Eo trên:

- Giới hạn: Eo trên được cấu tạo bởi: nền và cánh xương cùng, đường cung xương chậu, mao lược, mặt trên của xương mu và khớp mu.
Eo trên là phần hẹp mà đầu thai nhi bắt buộc phải đi qua trong quá trình sinh đẻ nên chúng có ý nghĩa trong sản khoa, eo trên là 1 mốc quan trọng xác định kiểu ngôi kiểu thế cho thai nhi.
- Tư thế: Eo trên chếch xuống dưới và ra trước. Phía sau eo trên có góc nhô và ụ nhô xương cùng gây hẹp đường kính trước sau, phía trước có mặt sau xương mu lồi vào lòng eo trên cũng làm hẹp đường kính trước sau.
- Hình thể: Eo trên có sự khác nhau tùy theo chủng và giới, nhưng thường cân đối, không lệch, hình dạng: tròn, hình bầu dục hoặc hình trái tim.
- Các đường kính eo trên có ý nghĩa quan trọng trong sản khoa, đánh giá sự rộng hẹp của eo trên, chúng gồm:

Các đường kính	Ở Việt Nam	Ở Châu Âu
Đường kính ngang lớn nhất	12 cm	13 cm
Đường kính ngang chính giữa	11.7 cm	12 cm
Đường kính chéo	11.6	12.5 cm
Đường kính trước sau: - Đường kính nhô - thượng vệ - Đường kính nhô – hậu vệ - Đường kính nhô – hạ vệ	11 cm 10.5 cm 12 cn	11.2 cm

(Đường kính nhô – hậu vệ = Đường kính nhô – hạ vệ - 1.5 cm)

- Đường kính ngang lớn nhất: nối 2 điểm xa nhất của eo trên, ĐK này nằm gần ụ nhô nên thai nhi không thể sử dụng ĐK này.
- Đường kính ngang chính giữa: đi qua trung điểm đường kính trước sau, ĐK này là ĐK hữu dụng có ý nghĩa.

Đường kính chéo: nối từ khớp cùng chậu đến gò chậu lược bên đối diện. ĐK chéo có ý nghĩa trong sản khoa vì là ĐK lọt của thai.

ĐK chéo trái là ĐK nối khớp cùng chậu phải đến gò chậu lược trái dài 12.5 cm.

ĐK chéo phải là ĐK nối khớp cùng chậu trái đến gò chậu lược phải dài 12 cm.

- Đường kính nhô – hậu mu: đi từ ụ nhô đến mặt sau xương mu. Đây là ĐK hẹp nhất của khung chậu (ĐK hữu dụng). Để xác định Đk này ta đo ĐK nhô hạ mu – 1.5 cm (thường là 10.5 cm).
Nếu ĐK nhô hậu mu < 8.5: Khung chậu hẹp tuyệt đối => Phải mổ lấy thai.
Nếu ĐK nhô hậu mu từ 8.5 – 10 cm: Khung chậu hẹp tương đối (Khung chậu giới hạn) => MLT / Để đường dưới tuỷ kích thước và ngôi thai. Kích thước thai to hoặc ngôi bất thường khác phải MLT.
Nếu ĐK nhô hậu mu ≥ 10 cm: Khung chậu bình thường.
 - Các số đo của các ĐK có thể khác nhau tùy theo tác giả. Trong thực tế sản khoa, người ta thường đo bằng cách đưa ngón trỏ và giữa vào trong âm đạo, tìm ụ nhô rồi đánh dấu mức bờ dưới xương mu trên ngón trỏ và đo khoảng cách từ đầu ngón tay đến điểm vừa xác định.
3. Sự khác nhau giữa khung chậu nam và nữ, UDLS:

Đặc điểm	Chậu hông nam	Chậu hông nữ	UDLS
Hình thể chung	Cao, hẹp (cái xô)	Rộng, thấp (cái chậu)	Giúp phụ nữ thuận lợi trong quá trình mang thai và sinh nở
Bề dày	Dày, nặng hơn Mào, củ, lồi, máu rở rết	Mỏng, nhẹ	Khung chậu nam chịu sức nặng tốt hơn, làm việc nặng hơn phụ nữ
Mào chậu		Dẹt, mỏng, cong hình chữ S	Thuận lợi cho thai lọt, sổ
Hố chậu		Lõm, sâu hơn	
Chậu hông bé	Thuôn dần từ trên xuống dưới	Gần như đều nhau	Thuận lợi cho thai sổ
Mặt phẳng eo trên	Nghiêng trên mặt phẳng ngang 54 độ	Nghiêng trên mặt phẳng ngang 58 độ	
Eo dưới	Tương đối hẹp	Tương đối lớn	Thuận lợi cho thai sổ
Ụ nhô, góc nhô		Rõ và lồi hơn	Ổ nữ là điểm tựa, móc cho thai xoay
Khớp cùng chậu	Vượt quá đốt sống SIII	Ngang đốt sống SIII	
Xương cùng	Dài, hẹp, lõm vừa phải	Ngắn, rộng, lõm nhiều hơn	Lọt xuống quy sổ
Lỗ bịt	Hình tròn	Hình tam giác	
Góc cung mu	Khoảng 85 độ	Rộng hơn, khoảng 105 độ.	Thuận lợi cho thai sổ

UDLS: Sự khác nhau giữa chậu hông nam và chậu hông nữ có ý nghĩa rất lớn trong sản khoa, pháp y và nhân chủng học

- Chậu hông nữ giúp thích nghi với thay đổi khi mang thai, giúp thai nhi đi qua ống đẻ dễ dàng hơn
- Chậu hông nam phù hợp với việc chống đỡ trọng lượng, chịu trọng tải lớn khi lao động nặng
- Trong pháp y: dựa vào hình dáng chậu hông để xác định giới tính của bộ xương
- Nhân chủng học: nghiên cứu tiến hóa và đặc điểm chủng tộc

Câu 2: Sự phát triển của các cơ quan sinh dục nữ, những bất thường (dị tật bẩm sinh thường gặp) của ống tử cung, âm đạo, UDLs:

I. Sự phát triển của các cơ quan sinh dục nữ:

1. Sự phát triển của buồng trứng:

- Buồng trứng bắt đầu biệt hoá từ tuần thứ 5 (muộn hơn tinh hoàn)
- Các thừng sinh dục nguyên thủy bị chia cắt thành các đám tế bào mầm nguyên thủy do sự tăng sinh của trung mô, tạo nên phần tuỷ buồng trứng.
Trong khi biểu bì bề mặt tăng sinh lần thứ 2 tạo nên các thừng sinh dục thứ phát hay thừng sinh dục vỏ, chứa các đám tế bào sinh dục nguyên thủy đã di cư tới.
- Vào tháng thứ 4, Các thừng sinh dục thứ phát bị chia cắt thành các đám tế bào bao quanh 1 hay nhiều tế bào mầm nguyên thủy.
Các tế bào mầm biệt hóa thành nguyên noãn bào và các nguyên noãn bào phân chia gián phân tích cực trong vỏ buồng trứng thành các noãn bào nguyên thủy.
Các noãn bào nguyên thủy được bao bởi các đám tế bào biểu mô - biệt hoá thành các tế bào nang.
Noãn bào nguyên thủy và tế bào nang bao quanh tạo nên 1 nang trứng nguyên thủy.

2. Sự phát triển của các ống sinh dục nữ:

2.1 Ống trung thận: kém phát triển hơn nam giới:

- Ống trung thận dọc phía trên buồng trứng: teo biến để lại di tích như hình giọt nước gọi là thủy bào có cuống dính vào loa vòi tử cung.
- Ống trung thận dọc và ngang buồng trứng: teo biến để lại di tích là các vật trên buồng trứng nằm giữa buồng trứng và vòi tử cung.
- Ống trung thận dọc phía ngay dưới buồng trứng: teo đi còn lại di tích là vật cạnh buồng trứng nằm giữa buồng trứng và tử cung.
- Ống trung thận dọc phía dưới trung thận thoái hóa và biến đi trong tháng thứ 4. Song đôi khi nó chỉ thoái hóa 1 phần để lại những u nang ở thành tử cung và âm đạo.

2.2 Ống cận trung thận: gồm 2 ống 2 bên, mỗi ống chia làm 3 đoạn:

- Đoạn đầu: biệt hóa thành đoạn loa vòi tử cung mở vào ổ bụng.
- Đoạn giữa (bắt chéo dây chằng bẹn): biệt hóa thành đoạn bóng và eo VTC.
- Đoạn cuối: sát nhập với đoạn tương ứng bên đối diện tạo ống tử cung âm đạo.
 - + Đoạn trên ống tử cung âm đạo: vách sát nhập teo đi tạo thân và eo. Lòng thân phát triển mạnh và tháng thứ 3 tạo 2 sừng tử cung ở nơi liên tiếp giữa VTC và tử cung.
 - + Đoạn dưới ống tử cung âm đạo: phát triển thành 1 phần cổ tử cung và phần trên âm đạo. Các tế bào biểu mô tăng sinh tạo lên 1 tấm lá biểu mô âm đạo (Ban đầu là khối đặc tế bào sau đó xuất hiện lòng ống do các tế bào lõi tiêu biến) .
Phần trên lá biểu mô tạo 1 phần CTC, phần dưới tạo lên đoạn trên âm đạo. Sự tiêu đi của biểu mô chỗ nối đoạn vây quanh cổ tử cung tạo 1 “vòm âm đạo” ở quanh CTC.

2.3 Xoang niệu sinh dục và sự phát triển của đoạn dưới âm đạo:

- Ống tử cung âm đạo tận cùng bằng đáy kín lồi vào thành sau của xoang niệu sinh dục thành củ Muller.
- Biểu mô xoang niệu sinh dục ở trước củ Muller dày lên góp phần tạo lên biểu mô âm đạo gọi là ‘lá’ (là khối tế bào đặc kín có hình trụ) sau đó biến thành 1 ống là âm đạo do sự tiêu đi của tế bào lòng ống.
- Sự tiêu hủy tế bào từ trên xuống dưới để lại 1 màng mỏng là màng trinh - màng ngăn cách âm đạo với đoạn chậu của xoang niệu dục. Cấu tạo màng trinh là màng liên kết mỏng phủ cả 2 mặt là biểu mô đoạn chậu xoang niệu sinh dục. Về sau màng trinh có lỗ thủng, đoạn chậu xoang niệu sinh dục dưới màng trinh thành tiền đình âm đạo.
- Biểu mô âm đạo có 2 nguồn gốc: 1 phần từ ống tử cung âm đạo, 1 phần từ xoang niệu sinh dục. => Thực tế khó phân biệt rõ rệt giữa 2 nguồn gốc.

3. Sự phát triển của cơ quan sinh dục ngoài.

- Phát triển dưới sự ảnh hưởng của nội tiết estrogen sinh ra bởi rau thai và người mẹ.
- Củ sinh dục phát triển nhẹ tạo âm vật.

- Các nếp sinh dục không sát nhập vào nhau như ở nam, biệt hoá thành môi nhỏ ở 2 bên tiền đình âm đạo.
- Các gờ sinh dục phát triển mạnh hơn tạo môi lớn.
- Tiền đình âm đạo do đoạn chấu của xoang niệu sinh dục tạo thành.
- Lỗ niệu đạo đổ vào tiền đình ở phía sau âm vật.

(Đoạn sinh dục của xoang niệu sinh dục ở dưới âm vật hầu như không đáng kể ở nữ.

Đoạn bàng quang của xoang niệu sinh dục phát sinh gần như toàn bộ niệu đạo nữ)

II. Những bất thường của ống tử cung, âm đạo:

- Do 2 ÔCCTT không sát nhập gây nhiều mức phân đôi ống tử cung âm đạo khác nhau: tử cung đôi: 2TC-2ÂĐ, 2TC-1ÂĐ, tử cung 2 sừng: 2 sừng-1 cổ, 2sừng - 2 cổ.
- Do 2 ÔCCTT sát nhập nhưng không tiêu vách: hình thái bên ngoài tử cung trông như bình thường, nhưng bên trong lại có 2 buồng: 2 buồng - 2ÂĐ, 2 buồng toàn bộ với 1 ÂĐ, 2 buồng 1 phần ở thân (do còn lại 1 phần vách ngăn ở đáy hoặc cổ).
- Do thiếu phát triển 1 bên ÔCCTT: Tử cung 1 sừng thật do không phát triển hoàn toàn 1 bên, hay 1 sừng với 1 vòi thô sơ.
- Do ÔTCÂĐ không phát triển: không phát triển 1 phần/hoàn toàn ÔCCTT và hành xoang âm đạo => không phát triển/hẹp TC hoặc ÂĐ, tật CTC, tật ÂĐ (do lá biểu mô ÂĐ không thông lòng, đôi khi hẹp 1 phần đoạn trên ÂĐ)
Hội chứng Rokitansky-kuster-hauser: TC chỉ có 1 khối nhỏ đại diện cho 2 sừng TC sơ khai + ÂĐ ít nhiều bị bịt kín.
- U nang thành TC / thành ÂĐ (u nang wofit): Do còn di tích ÔTT dọc.

Câu 3: Phân đoạn liên quan, cấu tạo, hình thể trong và UDLS với tử cung:

1. Đại cương:
 - Vòi tử cung hay vòi trứng là ống dẫn trứng từ BT vào TC
 - Gồm 2 ống P và T: dài 12cm, đi từ BT đến góc bên TC, nằm giữa 2 lá d/c rộng và chạy dọc bờ tự do của d/c này
 - Vòi tử cung là nơi xảy ra sự thụ tinh.
2. Phân đoạn: VTC chia làm 4 đoạn lần lượt từ ngoài vào:
 - 2.1 Phễu vòi/ Loa vòi:
 - Dài khoảng 1cm, loe ra như cái phễu, ở giữa là lỗ bụng/ lỗ ngoài của VTC. Qua lỗ này VTC thông với ổ phúc mạc và để dẫn trứng của BT vào vòi.
 - Xung quanh lỗ, phễu vòi có 10-12 tua vòi, trong đó có 1 tua dài nhất là tua BT có tác dụng hứng trứng đưa vào VTC.
 - Trong thời kỳ rụng trứng nhờ nội tiết tố, các tua vòi cương lên giúp hứng trứng rụng đưa vào VTC.
 - Phễu vòi có 2 mặt, mặt trong có các tua và úp mặt vào mặt trong buồng trứng.
 - 2.2 Bóng vòi:
 - Dài khoảng 7-8 cm, ĐK 7-8 mm, là đoạn phình to nhất của VTC (vị trí dễ thất VTC trong triệt sản)
 - Đoạn này chạy dọc theo bờ mạc treo của BT, giữa đoạn bóng và eo hợp thành 1 góc vuông, áp và thành bên chậu hông, có các vật trên BT.
 - Hiện tượng thụ tinh xảy ra ở $\frac{1}{3}$ ngoài VTC (đoạn bóng).
 - 2.3 Eo vòi:
 - Dài khoảng 3-4 cm, ĐK 3-4 mm, là đoạn hẹp nhất của VTC (thường tắc VTC ở đoạn này)
 - Đoạn eo tiếp theo đoạn bóng cho tới dính vào góc TC
 - Thông thường, trứng sau thụ tinh sẽ di chuyển về TC để làm tổ, vì 1 lý do nào đó mà thường do tắc đoạn eo làm trứng không vào TC, phát triển tại VTC $\Rightarrow$ gây ra GEU và thường sau 2-3 tháng sẽ gây vỡ VTC $\Rightarrow$ chảy máu ổ ạt (vì vỡ ĐM VT trong và ngoài)
 - 2.4 Phần TC:
 - Dài 1 cm, ĐK 5 mm, xuyên qua chiều dày thành TC và thông vào BTC bằng lỗ TC
 - Ứng dụng lỗ trong: Bơm hơi VTC, Chụp TC-VT cản quang, ...
3. Hình thể trong:

VTC cấu tạo gồm 4 lớp, lần lượt từ ngoài vào trong là:

 - Lớp thanh mạc: Do PM tạo lên, liên tiếp ở trong với thanh mạc TC
 - Lớp dưới thanh mạc
 - Lớp cơ: gồm 2 lớp: cơ dọc ở ngoài, cơ vòng ở trong, 2 lớp cơ này liên tiếp với lớp cơ TC
 - Lớp niêm mạc: Có nhiều nếp niêm mạc chạy dọc theo trục VTC. Trên bề mặt lớp niêm mạc là lớp tế bào có lông chuyển, chỉ chuyển động 1 chiều từ ngoài vào trong có tác dụng đưa trứng về TC.
4. Liên quan:
 - Đầu ngoài: Liên quan với ổ bụng, sát mặt trong buồng trứng.
 - Đầu trong: Liên quan BTC.
 - Bờ trên: Được d/c rộng chùm lên, liên quan với các quai ruột.
 - Bờ dưới: D/c rộng và nếp PM thông xuống ở dưới vòi được gọi là mạc treo vòi. Giữa 2 lá mạc treo, dọc theo bờ dưới của vòi có các nhánh vòi chưa ĐMTC và ĐMBT.
5. UDLS:
 - VTC là nơi diễn ra sự thụ tinh: xảy ra ở $\frac{1}{3}$ ngoài VTC (đoạn bóng vòi)
 - Đoạn bóng là vị trí thường bị thất và cắt để triệt sản nữ.
 - Phần eo là phần có ĐK nhỏ nhất + Đoạn bóng và eo tạo thành 1 góc vuông $\Rightarrow$ Đoạn eo là đoạn dễ tắc nhất, gây GEU do trứng không qua được đoạn này.

Câu 4: Hình thể ngoài, liên quan, vị trí, hướng và UĐLS của TC

Tử cung (dạ con):

- Là nơi nung nấu và phát triển của thai nhi.
- Khi thai đủ tháng, sự co bóp của TC góp phần đẩy thai nhi ra ngoài.
- Là nơi sản xuất ra kinh nguyệt.

1. Vị trí, hướng chiều:

- Vị trí: TC nằm giữa trong chậu hông bé, ở sau bàng quang, trước trực tràng, dưới các quai ruột, trên âm đạo.
- Hướng chiều: Tư thế bình thường của TC: gấp ra trước và ngả ra trước.
- Gấp ra trước: trục thân TC hợp với trục CTC 1 góc 120 độ quay ra trước.
- Ngả ra trước: trục thân TC hợp với trục ÂĐ/ chậu hông 1 góc vuông quay ra trước

=> Đây là tư thế lý tưởng của TC (TC trung gian) làm trọng tâm TC rơi vào phía trước trục ÂĐ => Giúp TC không bị sa xuống ÂĐ, góp phần giữ thai nhi trong TC (tránh sảy thai liên tiếp) và nguyên tắc chữa sa TC là làm TC gấp ra trước + ngả ra trước.

=> Do trục TC và ÂĐ gần như vuông góc nên khi nạo phá thai không cẩn thận/ thô bạo có thể chọc thủng túi cùng TC-Trực tràng nguy cơ gây viêm phúc mạc và tử vong.

2. Hình thể ngoài và liên quan:

- TC không có thai có hình nón cụt, dẹt theo chiều trước - sau, đáy hướng lên trên
- Kích thước TC thay đổi tùy trạng thái có thai hay không. Khi không có thai:
- TC dài 7-8 cm tùy tác giả: thân 5 cm, CTC 2.5 cm, eo 0.5 cm
- Dày (trước sau) 2cm, mỗi thành 1cm.
- Nặng 30-40 gram.
- TC gồm 3 phần : Thân, eo và CTC.

2.1 Thân TC:

- Vì thân TC hình nón cụt theo chiều trước sau nên thân TC có 2 mặt (mặt trước dưới là mặt bàng quang, mặt sau trên là mặt ruột), 2 bờ ở bên, đáy ở trên và 2 góc.

- 2 mặt:
- Mặt bàng quang: lồi hướng về phía trước dưới

Liên quan: PM: phủ mặt BQ của TC đến eo thì lật lên và ra trước phủ mặt đáy BQ, tạo túi cùng BQ-TC. Qua PM liên quan với BQ => Thai những tháng cuối to chèn ép bàng quang nên sản phụ hay đi tiểu vặt.

- Mặt ruột: Hướng lên trên và ra sau.

Liên quan: PM phủ mặt trên sau TC đến eo thì tiếp tục phủ $\frac{1}{3}$ trên ÂĐ rồi lật lên phủ mặt trước trực tràng, tạo túi cùng TC-TrTr (Túi cùng Douglas). Qua PM liên quan với quai ruột non, đại tràng xích ma và trực tràng. => Túi cùng Douglas là nơi thấp nhất của ổ PM nên dịch trong ổ PM sẽ đọng lại ở đây, khi khám lâm sàng bằng dấu hiệu Douglas phồng đau.

- 2 bờ P và T: dày và tròn có d/c rộng bám, dọc 2 bờ nằm trong 2 lá d/c rộng là ĐMTC và vật cạnh buồng trứng (di tích ÔTT).
- Đáy TC: là bờ trên của thân, có PM phủ liên tiếp từ mặt BQ lên mặt ruột. Đáy liên quan với quai ruột và đại tràng xích ma.
- Góc TC (sừng TC): 2 góc là nơi gặp nhau giữa 2 bờ và đáy TC, 2 sừng liên tiếp với đoạn eo của VTC. Bám vào 2 góc: VTC ở trên, d/c riêng buồng trứng ở giữa sau, d/c tròn ở dưới trước.

2.2 Eo TC:

- Eo là phần thắt lại nằm giữa thân và cổ
- Phía trước liên quan với: BQ và đáy túi BQ-TC. PM mặt trước phủ đến eo TC thì lật lên phủ BQ nên dễ bóc khỏi TC => Rạch vào eo TC trong mổ lấy thai.
- Phía sau và 2 bên eo tử cung có liên quan như mặt ruột và 2 bờ của thân tử cung.

2.3 Cổ tử cung:

- Là phần thấp nhất của TC, cổ có hình trụ và hẹp hơn thân.
- Âm đạo bám vào xung quanh CTC chia CTC thành 3 phần: phần trên ÂĐ, phần ÂĐ bám và phần trong ÂĐ.

- Phần trên ÂĐ: phía trước: không có PM phủ, liên quan ~ eo TC; hai bên cổ: có NQ chạy chéo xuống dưới và ra trước bị ĐMTC bắt chéo trước NQ và cách CTC 1.5cm; phía sau: có PM phủ lách xuống hết $\frac{1}{3}$ trên ÂĐ rồi lật lên phủ mặt trước trực tràng tạo túi cùng TC-TrTr (như đã mô tả mặt ruột)
- Phần ÂĐ bám: ÂĐ bám vòng quanh CTC theo 1 đường chéo xuống dưới và ra trước. Phía sau ÂĐ bám vào giữa CTC, phía trước ÂĐ bám $\frac{1}{3}$ dưới CTC.
- Phần trong ÂĐ: CTC thò vào ÂĐ như 1 mồm cá mè. Đỉnh mồm có lỗ vào TC: ở người chưa đẻ lần nào lỗ có hình tròn, ở người đẻ nhiều lần lỗ càng bè ngang và càng nhiều vết rách. Lỗ được giới hạn bởi 2 môi: môi trước và môi sau. Lỗ ngoài CTC được bịt bằng nút nhầy tác dụng tiêu diệt VK, giúp bảo vệ nội mạc TC tránh viêm nhiễm. Khi chuyển dạ, dưới tác dụng của những cơn co TC + hiện tượng xóa mở CTC đã đẩy nút nhầy ra ngoài => Đây là 1 trong các dấu hiệu chuyển dạ.
- Thành ÂĐ vây xung quanh CTC và bịt kín ở phần trên là vòm ÂĐ. Vòm ÂĐ là 1 túi bịt vòng gồm 4 phần: phần trước, sau và 2 bên. Phần sau sâu nhất liên quan trực tiếp với túi cùng Douglas, nên liên quan mật thiết với NQ, khi thăm túi cùng bên ÂĐ có thể phát hiện sỏi NQ.

3.UDLS:

- Túi cùng douglas là nơi thấp nhất của ổ phúc mạc, nên khi có dịch ổ bụng (viêm, xuất huyết...), dịch sẽ đọng tại đây; khám thấy dấu hiệu douglas phồng, đau
- Do trực tử cung và âm đạo gần như vuông góc nên khi nạo phá thai không cẩn thận có thể chọc thủng túi cùng tử cung - trực tràng nguy cơ gây viêm phúc mạc có thể dẫn đến tử vong.
- Phúc mạc mặt trước TC phủ đến eo rồi lật lên phủ bàng quang, dễ bóc tách, là cơ sở để rạch eo tử cung trong mổ lấy thai.
- Lỗ ngoài cổ tử cung được bịt bởi nút nhầy có tác dụng bảo vệ nội mạc tử cung khỏi viêm nhiễm. Khi chuyển dạ, nút nhầy bong ra ngoài, một trong những dấu hiệu chuyển dạ
- TC ngả trước, gập trước => Đây là tư thế lý tưởng của TC (TC trung gian) làm trọng tâm TC rơi vào phía trước trực ÂĐ => Giúp TC không bị sa xuống ÂĐ, góp phần giữ thai nhi trong TC (tránh sảy thai liên tiếp) và nguyên tắc chữa sa TC là làm TC gập ra trước + ngả ra trước.

Câu 5: Hình thể trong, cấu tạo tử cung và U'DLS

Tử cung (dạ con):

- Là nơi nung nấu và phát triển của thai nhi.
- Khi thai đủ tháng, sự co bóp của TC góp phần đẩy thai nhi ra ngoài.
- Là nơi sản xuất ra kinh nguyệt.

1. Hình thể trong:

- Lòng TC là 1 khoang rộng theo hướng trước sau, có 1 chỗ hẹp tương ứng với eo chia lòng TC thành 2 phần: trên là buồng TC, dưới là ống CTC
- Buồng TC: Là 1 khoang rộng vì 2 thành trước và sau áp sát vào nhau. Hình tam giác mà đáy là mặt trong đáy TC: đáy hơi lõm ở người chưa đẻ, phẳng lõm ở người đẻ hoặc đẻ nhiều lần.
- Hai bờ bên: cũng lõm
- Hai góc trên là 2 lỗ TC của VTC
- Ống CTC: Là 1 hình thoi với 2 thành trước và sau, rộng ở giữa và hẹp ở 2 đầu
- Ở trên: ống thông với BTC qua 1 lỗ hẹp là lỗ trong CTC
- Ở dưới: ống thông với ÂĐ qua lỗ ngoài CTC
- Thành trước và sau của ống CTC có 1 lỗ dọc, nằm không đúng đường giữa và 2 bờ này không đè lên nhau. Từ mỗi lỗ dọc có các nếp chạy chéo lên trên và ra ngoài gọi là nếp lá cọ.

2. Cấu tạo:

Thành TC gồm 4 lớp lần lượt từ ngoài vào trong là:

2.1 Áo thanh mạc:

- Là lớp PM, ở 2 bờ của thân TC không có PM che phủ.
- PM mặt BQ: phủ mặt BQ của TC đến eo TC thì lật lên phủ đáy BQ => Túi cùng BQ-TC
- PM mặt ruột: PM phủ mặt trên sau BQ tới eo rồi tiếp tục phủ đến $\frac{1}{3}$ trên ÂĐ thì lật lên phủ mặt trước TrTr => Túi cùng TC-TrTr (Túi cùng Douglas).

2.2 Tấm dưới thanh mạc: Là lớp mô liên kết sợi dính vào TC

2.3 Áo cơ:

- Lớp dày nhất TC. Phụ nữ chưa sinh đẻ: cơ dày, đặc, cắt qua lớp này cảm giác như cắt qua sụn, dày 1.25 cm (ở thân)
- Gồm các sợi cơ trơn đan xen với MLK, MM, TK
- Trong thời kỳ mang thai lớp cơ này rất phát triển
- Gồm 3 lớp:
- Lớp ngoài: Chủ yếu là sợi dọc chạy về đáy TC và hội tụ ở 2 sừng TC, liên kết với cơ của VTC
- Lớp giữa: Lớp cơ rối: Các cơ chạy theo nhiều hướng, đan chéo nhau, chằng chịt quay xung quanh mạch máu. Khi lớp cơ này co có tác dụng cầm máu sau đẻ.
=> Trường hợp đẻ TC: lớp cơ này không co hoặc co không đủ mạnh gây băng huyết, chảy máu sau đẻ.
- Lớp trong: Lớp cơ vòng
- Ở CTC cơ mỏng hơn nhiều cũng gồm 3 lớp: trong đó lớp giữa là lớp cơ vòng không phải cơ rối => Rau tiền đạo, rau cài răng lược gây chảy máu nhiều, băng huyết trong 3 th cuối / khi sổ rau.

2.4 Niêm mạc tử cung: niêm mạc thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, hằng tháng niêm mạc bong ra kết hợp chảy máu tạo nên chu kỳ kinh nguyệt. Trong lớp niêm mạc có nhiều tuyến, gọi là tuyến tử cung.

3. U'DLS

- Rau thai bình thường bám vào BTC, bất thường khi rau bám thấp xuống đoạn dưới gọi là Rau tiền đạo nguy cơ gây chảy máu 3th cuối và trong khi chuyển dạ.
- Nếp lá cọ: giúp 2 thành trước và sau của ống CTC ép chặt vào nhau ngăn cách BTC với ÂĐ, kết hợp với chất dịch CTC tiết ra ở môi trường acid giúp ngăn VK từ ÂĐ xâm nhập vào gây viêm NMTC

Câu 6: Tinh hoàn: Sự di chuyển, hình thể ngoài, cấu tạo và UDLS

Tinh hoàn là 1 tuyến vừa ngoại tiết (sản xuất tinh trùng), vừa làm tuyến nội tiết (tiết ra Hormon nam giới là testosterone, làm cơ thể phát triển theo kiểu hình nam tính).

1. Sự di chuyển của tinh hoàn:

- Tinh hoàn phát sinh rất cao ở sát thành lưng của phôi gần hố thận.
- Cuối tháng T2, tinh hoàn ngày càng biệt hóa tách khỏi trung thận.
- Mạc treo niệu SD sau trở thành mạc treo trung thận, khi trung thận thoái hóa nó thành d/c hoành dính vào cực trên của tuyến SD và d/c bên dính vào cực dưới. D/c bên là dây lái tinh hoàn cuối cùng tạo nên bởi phần còn lại của mạc treo niệu SD và gồm những sợi đi từ cực dưới tinh hoàn tới gờ bìu.
- Vào tháng T2 của sự phát triển, thân phôi tăng trưởng rất nhanh, dây lái tinh hoàn không dài ra tương xứng vẫn giữ tinh hoàn ở vị trí gần bìu. (Tinh hoàn di chuyển xuống thấp dần từ thành sau cơ thể).
- Vào tháng T5, tinh hoàn nằm gần vùng bẹn, sau PM.
- Vào tháng T6, tinh hoàn nằm ở lỗ bẹn sâu, đi qua ống bẹn vào tháng T7, đến vị trí vĩnh viễn vào tháng T8. (Tuy nhiên có sự khác nhau về thời gian di chuyển giữa các tác giả)
- Trong quá trình di chuyển trên ổ bụng tinh hoàn đều nằm sau PM, đến khi bắt đầu chui qua ống bẹn nó kéo theo PM quanh nó đi xuống tạo mồm bao tinh hoàn (mồm bao hay ống phúc tinh mạc vì là 1 ống chui qua ống bẹn nối giữa PM và mạc bọc tinh hoàn).
- Mồm bao sau này bít lại và xơ hóa thành 1 d/c gọi là di tích mồm bao tinh hoàn (d/c phúc tinh mạc)
- Phần PM bọc tinh hoàn ở trong bìu được gọi là bao tinh hoàn hay áo bao tinh hoàn

2. Hình thể ngoài:

- Vị trí: TH nằm trong bìu, TH (T) thấp hơn TH (P) ~ 1cm
- TH phát triển nhanh trong quá trình trưởng thành.
- Hình dạng TH: Hình bầu dục, dẹt, mặt nhẵn, màu trắng xanh
- Trục TH: hướng xuống dưới và ra sau
- Ở người trưởng thành, TH có KT: 4.5x2.5x1.5 cm (c r d), trọng lượng thay đổi, trung bình 15-20gram
- TH sờ chắc, hơi rắn, nắn có cảm giác đau đặc biệt
- TH có: + 2 mặt: mặt trong phẳng, mặt ngoài hơi lồi
 - 2 bờ: trước và sau
 - 2 cực: cực trên có mào tinh chụm vào, 1 mấu nhỏ gọi là mấu phụ tinh hoàn (di tích ÔCTT); cực dưới có d/c bìu cố định TH vào bìu.
- Bao TH: TH bao bọc bằng 1 lớp vỏ dày trắng và không đàn hồi (lớp trắng).

3. Cấu tạo:

- Trên thiết đồ bỏ dọc, TH được chia thành nhiều tiểu thùy ~ 200-300 tiểu thùy/ 1 TH
- Các tiểu thùy được ngăn cách bằng các vách TH: vách không hoàn toàn, vách đi từ mặt trong áo trắng hướng lên trên để hội tụ ở góc trên TH, tạo lên ở đây thành 1 chỗ dày gọi là trung thất TH.
- Tiểu thùy TH: + Có hình nón, nền áp vào áo trắng, đỉnh hội tụ ở trung thất TH.
 - Có 2-4 ống sinh tinh xoắn/ 1 tiểu thùy, 1 ống dài 0.7m, ĐK 0.1-0.3mm
 - Ống chứa các tế bào có chức năng sinh ra tinh trùng
- Tinh trùng được sinh ra từ ÔSTX đổ vào ÔST thẳng: đi từ đỉnh tiểu thùy đến mạng tinh nằm dưới trung thất tinh hoàn.
- Giữa các ÔSTX là các đám tế bào kẽ, nơi tiết ra Testosterone.

4. UDLS

- Trong thời kỳ phôi thai: TH phát sinh ngang mức thận, trong quá trình di chuyển kéo theo mm, tk, bh từ vùng này xuống
=> Đau ở thận thường lan xuống bìu và ngược lại đau tinh hoàn lan lên thất lưng
- TH không xuống bìu: TH nằm bất cứ nơi nào trên đường đi xuống: ổ bụng, ống bẹn, lỗ bẹn nông, phần trên của bìu

=> Cần phân biệt với:

+ Tình hoàn bị co rút: Trẻ em, do cơ búi co kéo TH lên. => Điều trị: Ấn nhẹ tay từ phía trên, tắm nước nóng để giãn cơ đưa TH về vị trí cũ.

+ Tình hoàn lạc chỗ: TH đi xuống nhưng không nằm trên đường di chuyển sẽ ảnh hưởng đến chức năng => Cần phẫu thuật đặt lại về vị trí. Hay gặp nhất TH đi ra ngoài sau khi qua lỗ bẹn nông, nằm trên d/c bẹn, trước mu, đáy chậu, trên đùi,...

- Tìm sự di căn của khối u TH theo đường bạch huyết: sờ kỹ, siêu âm kỹ trên bụng
- Hạch cạnh ĐMC to ở 1 hoặc 2 bên (vì các hạch 2 bên thông nối nhau qua đường giữa)
- Hạch bẹn to: Nhiều người chỉ khám hạch bẹn khi khối u đã loét ra búi đã bỏ qua hạch cạnh ĐMC (vì khối u đã xâm lấn hạch bạch huyết dẫn tới hạch bẹn)
- Giãn tĩnh mạch thừng tinh (giãn đám rối TM hình dây leo):
- Tiến triển nhanh là dấu hiệu u thận (T): Khối u xâm lấn TM thận (T) gây nghẽn dẫn lưu TM TH (T): hiếm gặp
- Đa số do tự phát, T>>P: CRNN, nhiều tác giả cho rằng TM TH (T) do bị chèn ép bởi: đại tràng xích ma chứa đầy phân, góc gấp chỗ TM này đổ vào TM thận (T), co thắt do TM thận chứa nhiều adrenalin từ TM thượng thận đổ vào.

Câu 7: Ống dẫn tinh: phân đoạn, liên quan và UDLS

- ÔDT là ống dẫn tinh trùng
 - Đi từ đuôi mào TH đến niệu đạo đoạn tiền liệt ở gò tinh
 - KT: dài 40-45cm, ĐK ngoài 3mm - trong 0.5mm.
 - Đặc điểm: thành dày, dễ nhận biết, khó bị xẹp và tắc ống
 - Gồm 5: đoạn bìu, đoạn thừng tinh, đoạn chậu hông, đoạn sau BQ và đoạn tiền liệt
1. Đoạn bìu (mào tinh):
 - Từ đuôi mào tinh đến cực trên tinh hoàn: chạy lên dọc bờ sau, mặt trong mào tinh.
 - Ban đầu xoắn, sau chạy thẳng.
 2. Đoạn thừng tinh:
 - Từ cực trên TH đến lỗ bẹn sâu
 - Phôi thai: TH di chuyển xuống bìu kéo theo mm, tk, bh gặp nhau ở lỗ bẹn sâu thành dây kéo tinh hoàn (thừng tinh): gồm 3 lớp áo và 7 thành phần
 - 3 lớp áo thừng tinh:
 - Mạc tinh ngoài: do cơ chéo bụng ngoài
 - Cơ bìu: do cơ chéo bụng trong
 - Mạc tinh trong: do mạc ngang
 - 7 thành phần: Ống dẫn tinh, ĐM TH, ĐM ÔDT, ĐM cơ bìu, TM TH (hình dây leo), TK sinh dục đui, mạch BH và mô liên kết.
 - => Áp dụng: Đoạn này ÔDT nằm ngang dưới da, trước xương mu => dễ thắt để triệt sản nam
 3. Đoạn chậu: Áp vào thành chậu hông
 - Từ lỗ bẹn sâu đến mặt sau BQ
 - Liên quan:
 - Ngoài ĐM thượng vị dưới
 - Bắt chéo ĐM chậu ngoài
 - Bắt chéo trước NQ
 4. Đoạn bàng quang:
 - Liên quan: nằm trong túi tinh tạo tam giác gian ÔDT nằm trong tam giác gian túi tinh.
 - Túi tinh phình to tạo bóng ÔDT, bắt chéo trước NQ
 5. Đoạn tiền liệt:
 - ÔDT hợp với ống túi tinh tạo ống phóng tinh: xuyên chéo qua TLT ~ 2cm đổ vào mặt sau NĐ đoạn tiền liệt 2 bên lồi tinh.
- => Áp dụng: Nhiễm trùng từ BQ, NĐ lan lên mào tinh nhất là sau cắt TLT: Nhiều PTV phải cắt bỏ ÔDT trong cắt bỏ TLT để giảm biến chứng.
- *** Áp dụng lâm sàng:
- Triệt sản: thắt và cắt ÔDT đoạn thừng tinh là tiểu phẫu dễ thực hiện qua da. Hiểu giải phẫu sẽ tránh được tổn thương TK, MM, tinh hoàn.
 - Cắt ÔDT trong PT cắt TLT để giảm nhiễm trùng lan từ BQ, NĐ lên Mào tinh. Nhiễm khuẩn từ BQ, NĐ lan lên mào tinh.
 - Tắc ÔDT: gây vô sinh nam: Do viêm, chấn thương hoặc bẩm sinh.
 - Phẫu thuật thăm dò: chú ý niệu quản, túi tinh, mm tránh biến chứng
 - UT tinh hoàn di căn theo đường bạch huyết ÔDT lên bụng trên
 - Khám LS: ÔDT có thể sờ thấy nhờ áo cơ dày. Nếu sờ thấy phình ống hoặc đau có thể do viêm, tắc hoặc u.

Câu 8: Cấu tạo dương vật, giải thích cơ chế cương dương vật, U'DLS

Dương vật đảm nhiệm 2 chức năng: Niệu và sinh dục

1. Hình thể ngoài: gồm gốc (rễ), thân và đầu trước (quy đầu)
 - Rễ: Cố định bởi d/c treo DV và xương mu. Vật hang treo vào ngành dưới xương mu. Vật xóp treo vào đáy chậu.
 - Thân: Hình trụ dẹt theo chiều trước sau, 2 mặt:
 - Mặt mu DV: phía trên, phía lưng hơi dẹt
 - Mặt niệu đạo: phía dưới, có đường đan DV chạy dọc giữa mặt dưới.
 - Đầu trước/ quy đầu:
 - Bọc bằng BQĐ: nếp nửa da nửa niêm mạc, mặt dưới có hãm BQĐ => BQĐ trẻ em rất dài không thể trật lên: hẹp BQĐ/ BQĐ dài. Sau này khi cương dương có thể hẹp BQĐ cấp cứu => thường cắt lúc 5-6 tuổi
 - Vành BQĐ: bờ lõm chạy chéo xuống dưới và ra trước
 - Cổ quy đầu: nằm giữa thân và vành quy đầu.
 - Lỗ sáo, lỗ ngoài niệu đạo
2. Cấu tạo: Gồm các tạng cương và các lớp bọc DV
 - 2.1 Các tạng cương: 2 vật hang và 1 vật xóp:
 - Hình thể:
 - Vật hang: dài 15cm khi mềm, 2 vật hang hình trụ dẹt thu hẹp ở phần đầu
 - Phần sau trụ DV dính vào ngành dưới xương mu, có cơ ngồi hang ôm quanh 3 mặt tham gia tạo rễ DV
 - Phần trước: 2 vật hang đi // nhau như 2 nòng súng tới vành BQĐ thu hẹp lại tham gia tạo thân DV
 - Vật xóp: Hình trụ dẹt, nằm trong rãnh dưới giữa 2 vật hang, trong có NĐ
 - Phần sau: phình to gọi là hành xóp tham gia tạo rễ DV
 - Phần trước: tạo thân DV, liên tiếp với mô xóp quy đầu tạo quy đầu
 - Cơ hành xóp dính nhau ở đường giữa như 1 cái võng, tách ra 1 bó dính với bên đối diện, bó này chèo lên trên xương mu
 - Cấu tạo: Bao bọc xung quanh tạng cương là lớp áo trắng, lớp này đi vào nhu mô tạo vách VH và vách VX => Chia VH và VX thành các hang, hốc nhỏ như tổ ong gọi là hang VH, hang VX. Các hang này chứa đầy máu làm cương các tạng cương.
 - Cơ ngồi hang và cơ hành xóp co -> máu dồn ra trước và trong các tạng cương và không cho máu trở về tạo lên sự cương dương.
 - 2.2 Các lớp bọc DV: có 4 lớp từ ngoài vào trong:
 - Da: mềm, mỏng, rất chun giãn, liên tiếp với BQĐ, dưới chứa nhiều TM nông (sẫm màu), liên kết với cơ dartos nên khi kích thích da cũng gây cương DV
 - Mạc nông DV: Không có mô mỡ, chỉ là mô liên kết lỏng lẻo chứa cơ trơn dartos, mạc nông liên tiếp với mạc đáy chậu trước
 - Mạc sâu DV (Mạc Buck): lách giữa các tạng cương, bao quanh VH, VX; phía dưới có mm, tk
 - Lớp áo trắng VH, VX
3. Mạch máu, thần kinh:
 - ĐM: 2 ĐM:
 - ĐM nông: ĐM mu DV: chạy dọc lưng DV, dưới lớp mạc sâu DV, nhánh nằm trong mô nhão dưới da: từ ĐM thẹn ngoài, ĐM đáy chậu nông
 - ĐM sâu: ĐM sâu DV: có 1 ĐM sâu chạy giữa VH, không có TM đi cùng (cấu tạo này cũng giúp cho cương dương), tách từ ĐM thẹn trong.
 - TM: Các TM mu DV đổ về TM sâu DV
 - BH: BH nông DV đổ về hạch bẹn nông, BH sâu DV đổ về hạch bẹn sâu
 - TK: TK mu DV tách từ TK thẹn, TK hang DV thuộc thần kinh tự chủ.
4. Cơ chế cương DV:

- Khi sự kích thích hay ham muốn tình dục tác động trực tiếp/ gián tiếp lên DV (Đặc biệt phần dưới BQĐ => (+) phát ra 1 tín hiệu từ não bộ chuyển đến trung tâm gây cương ở tủy sống làm nó hoạt động => tín hiệu gửi tới mô cương trong 2 thể hang (qua sợi TK thể hang)
- Kết quả:
- Làm giãn nở các ĐM thể hang, ĐM nhỏ, kể cả ĐM xoắn => máu bơm dồn về các hang
- Các cơ trơn quanh ĐM hang, cơ trơn quanh các hang mm giãn ra => tạo lực hút cho máu đến các hang mm nhiều hơn => Yếu tố chính gây cương dương/xìu DV
- Sự giãn nở các hang mm làm máu về hang nhiều => làm tăng áp lực hang => Hang phình ra ép lên TM gây xẹp TM => Máu ứ lại không thoát về nên gây cương dương (Cơ chế gây cương do TM bị chèn ép).

5 UDLS:

- RL cương dương:
 - + Nguyên nhân: Do MM kém, TK tổn thương, bất thường hormon, TDP thuốc.
 - + Điều trị: Thuốc ức chế PDE-5 (tăng cGMP Tăng giãn mạch thể hang)
 - Tiêm thuốc giãn mạch trực tiếp vào thể hang
 - Đặt vật hang nhân tạo khi điều trị bảo tồn thất bại
- Đánh giá lưu lượng máu thể hang/ vật xóp: Siêu âm Doppler DV: Xác định khả năng tăng tưới máu khi cương dương, mức độ tắc nghẽn TM
 - ⇒ Phân biệt NN thiếu máu và rò TM.
- PT chỉnh hình DV:
 - + Cắt da thừa, tái tạo mô xóp, vật hang
 - + Chỉnh dị dạng bẩm sinh: hẹp BQĐ, cong DV,...
 - + Khi phẫu thuật, hiểu giải phẫu và cơ chế cương dương sẽ tránh tổn thương MM, TK
 - ⇒ Duy trì khả năng cương dương sau mổ
- Điều trị RL xuất tinh, RL giao hợp: Kiểm soát cơ cơ trơn, TK cảm giác, Hormon: UD thuốc và liệu pháp vật lý.
- Hẹp BQĐ cấp cứu: PT cho trẻ sớm từ 5-6 tuổi

Câu 9: Vòng tuần hoàn thai nhi và những biến đổi sau sinh, U'DLS

Khi còn trong TC thai nhi sống được là nhờ dinh dưỡng và O₂ trong máu mẹ từ bánh rau tới

1. Đặc điểm vòng tuần hoàn thai nhi:

- Máu nuôi thai nhi là máu pha: Lượng HC cao => sau sinh vỡ ra gây vàng da sinh lý
- Phổi chưa hoạt động: Các phế nang xẹp, các phế quản chưa giãn nở, tỷ trọng nặng hơn nước (Có ý nghĩa trong pháp y)
- Tồn tại lỗ bầu dục: lỗ thông liên nhĩ (lỗ botal)
- Tồn tại ÔĐM: ống nối thông giữa ĐMP và cung ĐMC (phần xuống) sau khi cung ĐMC tách ra thân ĐM cánh tay đầu, ĐM cảnh (T) và ĐMDĐ (T). Máu đi từ ĐMP đến phần xuống cung ĐMC
- Tồn tại TMR: TM mang máu đỏ tươi giàu O₂ và chất dinh dưỡng chạy từ bánh rau đến mặt dưới gan, đổ vào ngành trái của TM cửa.
- Tồn tại ÔTM (Ống TM arantius): TM này ở dưới gan, nối TMR với TMC
- Tồn tại ĐMR: 2 ĐMR: xuất phát từ ĐM chậu trong chạy lên trên và vào trong hướng tới rốn và đi trong dây rốn (thừng rốn) để mang máu pha đến bánh rau, góp phần vào việc trao đổi chất giữa máu mẹ và thai nhi

2. Biến đổi sau sinh:

- Sau khi trẻ sinh ra: Dây rốn bị thắt lại và cắt làm ngừng tuần hoàn giữa máu mẹ và con -> Ph máu và lượng CO₂ của trẻ tăng lên -> kích thích trung tâm hô hấp ở hành não làm đưa trẻ bắt đầu thực hiện hô hấp, thể hiện bằng tiếng khóc đầu đời -> phổi hoạt động: Từ nhu mô xẹp, đặc sang phế nang giãn to ra, phế quản giãn nở, mm giãn nở -> Tăng Vphổi mạnh mẽ -> Pphổi giảm -> Hút máu từ ĐMP vào phổi

=> Máu từ ĐMP không qua ÔĐM vào cung ĐMC nữa, dần dần ÔĐM đóng lại và teo đi thành d/c ĐM (Thường sau sinh 3-4 tháng thì hết hoàn toàn ÔĐM)

- Vì máu hút mạnh về phổi, máu qua ĐMP nhiều -> Áp lực TT(P) giảm mạnh -> Máu từ TN(P) hút mạnh về TT(P) làm áp lực TN(P) giảm, mặt khác máu lên phổi nhiều rồi về TN(T) làm tăng áp lực TN(T) ép vách nguyên phát vào vách thứ phát.

=> Lỗ Botal dần đóng lại (Khoảng giữa T6-T10 sau sinh thì hết hoàn toàn): di tích là hố lõm hình bầu dục ở mặt (P) của vách liên nhĩ

- Do máu không qua TMR, ĐMR và ÔTM nên chúng dần teo đi và trở thành các di tích:

TMR -> d/c tròn của gan; ÔTM -> d/c TM ; ĐMR -> thừng ĐMR. Riêng ĐMR không teo đi toàn bộ mà chỉ teo ở đoạn xa nguyên ủy của ĐM thành thừng ĐMR (tháng 2-3 sau sinh). Phần gần nguyên ủy ĐM: không teo, trở thành ĐM BQ trên cấp máu cho BQ.

3. U'DLS

- Quá trình thay đổi trên có thể bất thường gây dị tật bẩm sinh: TLN, còn ÔĐM,...
- Sau sinh 10 tháng: máu trẻ trở về bình thường: Vhc, chỉ số HC về bình thường.

Câu 10: Hình thể ngoài, liên quan của trực tràng, UĐLS

1. Đại cương:

*) Vị trí, chức năng, kích thước:

- Trực tràng là phần cuối ÔTH/ đại tràng. Chức năng: Chứa phân
- Vị trí: Ở trên: liên tiếp với ĐT xích ma ngang đ/s SIII; Ở dưới tận hết bởi hậu môn.
- Kích thước: Dài: 12-16cm: phần trên BTT cao 10-12cm, phần dưới ÔHM cao 4cm (Kích thước này khác nhau tùy tác giả). V: 250-500ml phân

*) Hướng, chiều:

- Nhìn theo chiều trước sau là ống thẳng
- Nhìn nghiêng:
- Phần BTT: cong lõm trước theo chiều cong mặt trước xương cùng cụt đến đỉnh xương cụt thì liên tiếp với ÔHM.
- Phần ÔHM: Chạy chéo xuống dưới và ra sau, quay chiều lõm về phía sau. BTT vuông góc với ÔHM => Giúp giữ TrTr cố định tại chỗ không bị tụt xuống; chỗ bẻ gấp rất gây trở ngại cho việc thăm TrTr

*) Về phôi thai: 2 nguồn gốc, nhiều tác giả mô tả BTT và ÔHM thành 2 phần riêng biệt, có người lại mô tả TrTr gồm 2 phần BTT và ÔHM.

- Nguồn gốc BTT: Thuộc phần cuối ÔTH
- Nguồn gốc ÔHM: Thuộc ổ nhóp đáy chậu

2. Hình thể ngoài, liên quan:

2.1 Bóng trực tràng: là ống phình to

*) Mặt trước:

- Phúc mạc: Không phủ hoàn toàn TrTr: mặt trước PM phủ $\frac{1}{3}$ trên rồi lật lên tạng SD, 2 bên PM phủ $\frac{1}{4}$ trên. Đường bám PM có hình chữ U, nét ngang ở mặt trước, nét thẳng ở 2 bên.
- Liên quan với các tạng khác nhau ở nam và nữ:
- Nam:
 - Liên quan với mặt sau BQ, túi tinh, ÔDT: 2 túi tinh tại tam giác gian túi tinh, 2 ÔDT tạo tam giác gian ÔDT.
 - Niệu quản lách giữa túi tinh và BQ
 - Túi cùng BQ TrTr chứa các quai ruột.
- Nữ:
 - Liên quan TC, ÂĐ
 - TC: Túi cùng Douglas: túi PM thấp nhất của chậu hông: đọng dịch (máu, mủ,...) có các quai ruột non lách vào.
 - ÂĐ: Vách ÂĐ TrTr có thể bị rách trong đẻ khó can thiệp thô bạo/ không đúng phương pháp tạo lỗ rò TrTr ÂĐ.

*) Mặt sau:

- Liên quan mặt trước xương cùng, xương cụt, các thành phần trước xương (ĐM cùng, ĐRTK cùng, chuỗi hạch ĐRGC cùng, chỗ bám cơ hình lê)
- Ngăn cách nhau bằng mô mỡ nhão => Dễ bóc tách Tr Tr ra

*) Mặt bên:

- Phần PM: 2 bên PM phủ $\frac{1}{4}$ trên rồi lật lên 2 bên chậu hông tạo túi cùng bên. Túi cùng bên có các quai ruột, ĐT xích ma, nữ có thêm buồng trứng và phễu vòi
- Phần dưới PM: ĐM TrTr giữa, cơ nâng HM, khuyết ngồi lớn và các thành phần đi qua: cơ hình lê, mm, tk qua phía trên dưới cơ hình lê.

2.2 Ống hậu môn:

- ÔHM đi từ đỉnh xương cụt qua hoành chậu hông tới hậu môn
- Phía trong thành ÔHM có cơ thắt trơn HM (Cơ thắt HM trong)
- Phía ngoài, xung quanh ÔHM có cơ thắt vân HM (Cơ thắt HM ngoài): liên tiếp với cơ nâng HM
- Liên quan:

- Phía trước: Trung tâm gân đáy chậu (Nơi tiếp nối giữa đáy chậu trước (vùng niệu SD) và đáy chậu sau (vùng HM))
- Phía sau: Đường HM cắt
- 2 bên: 2 hố ngồi TrTr (hậu môn). Hố ngồi TrTr hình tam giác:
 - Thành ngoài: mạc và cơ bịt trong
 - Thành trong và trên: cơ nâng HM + cơ thắt HM ngoài
 - Thành dưới: da + mỡ dưới da vùng HM chứa mô mỡ nhão, ít mm, tk
=> NK dễ lan vào hố này và lâu khỏi hay gây rò HM.

3. UDLS

- Tư thế ÔHM vuông góc BTT: Giữ cố định TrTr không sa xuống, giữ phân không tuột ra ngoài, gây cản trở trong thăm TrTr.
- Thăm dò HM: Dùng ống soi/ bằng tay: Sờ thấy khối u hoặc búi trĩ, thấy các tạng lân cận: TLT, buồng trứng, túi cùng douglas. Phát hiện sớm UT TrTr qua thăm TrTr.
- Đặt thuốc giảm đau HM: Đặt vùng búi trĩ: nhiều TM hấp thu nhanh (~2-3cm từ rìa HM/ qua cơ thắt trong HM thì dùng)
- Thụt HM: Đưa lòng ống vào bóng HM
- Hố ngồi TrTr: Thành dưới có mô mỡ dưới da vùng HM chứa mô mỡ nhão, ít mm tk =>NK dễ lan vào, lâu khỏi gây rò HM, khi nạo vét áp xe thì chú ý thận kinh thận tránh tổn thương sẽ gây mất cương dương ở nam.
- BTT có khả năng giãn nở lớn, khi căng gây cảm giác mất đại tiện
⇒ Nếu RL chức năng: gây táo bón, són phân.

Câu 11: Hình thể ngoài, liên quan, UDLS của âm đạo

Âm đạo là ống cơ mạc, bám từ cổ tử cung tới tiền đình âm hộ. Ống rất đàn hồi, dài trung bình 8cm. Âm đạo nằm sau bàng quang, trước trực tràng, chạy chéo ra trước, xuống dưới theo trục chậu hông, nên trục âm đạo hợp với đường ngang một góc 70 độ quay ra phía sau. Hai thành trước và sau âm đạo áp sát vào nhau và thành sau dài hơn thành trước 1-2 cm.

Liên quan: Âm đạo có 2 thành trước và sau, hai bờ bên và hai đầu trên dưới

- Thành trước: Liên quan ở trên với bàng quang và niệu quản, ở dưới với niệu đạo. Giữa âm đạo và các cơ quan này là một tổ chức liên kết. Trong trường hợp đẻ khó, có thể rò bàng quang âm đạo, do thành âm đạo bị rách

- Thành sau: liên quan từ trên xuống dưới với túi cùng tử cung trực tràng, rồi tới mặt trước trực tràng cho tới tận mạc đáy chậu. Ở phía trên lớp mạc cơ đáy chậu, khi âm đạo tiếp tục chạy chéo ra trước thì ống hậu môn bẻ gấp ra phía sau, tạo nên một tam giác giữa âm đạo và ống hậu môn, gọi là tam giác âm đạo trực tràng. Âm đạo cũng ngăn cách với trực tràng qua một vách mô liên kết xơ. Có thể bị rò âm đạo trực tràng trong những trường hợp đẻ khó như trong rò bàng quang âm đạo.

- Bờ bên âm đạo, ở trên, bờ nằm trong khoang chậu hông, liên quan với dây dây chằng rộng, ở đó có niệu quản và các nhánh mạch thần kinh âm đạo, cũng như mô liên kết trong khoang chậu hông dưới phúc mạc. Ở giữa âm đạo chọc qua hoành chậu hông. Và ở dưới âm đạo vào vùng đáy chậu, liên quan với cơ khí âm môn, tuyến tiền đình.

- Đầu trên bám xung quanh vào cổ tử cung tạo nên vòm âm đạo, vòm âm đạo sâu 2cm, liên quan với túi cùng tử cung trực tràng. Vì vậy qua vòm sau âm đạo có thể thăm khám hay thực hiện thủ thuật vào túi cùng này

- Đầu dưới mở vào tiền đình âm hộ. Ở người phụ nữ chưa qhđ, lỗ của đầu dưới âm đạo được đẩy bởi 1 nếp niêm mạc thủng ở giữa gọi là màng trinh, sau khi giao hợp màng trinh bị rách, những mảnh rách của màng trinh xung quanh lỗ này gọi là cục màng trinh. Lỗ dưới âm đạo được các thớ sợi của cơ hành xếp bao quanh như một cơ thắt âm đạo

UDLS:

- Người nạo thai không chuyên hay thiếu kinh nghiệm có thể không nhận thấy tử cung chạy lên trên và ra trước từ đầu trên âm đạo, mà có thể đẩy dụng cụ thẳng ra phía sau túi cùng sau âm đạo thay vì đưa vào cổ tử cung. Dẫn tới thủng túi cùng sau. Điều này càng tồi tệ hơn, vì túi cùng sau là phần duy nhất của âm đạo liên thông với phúc mạc nên dụng cụ đi vào ổ phúc mạc gây viêm phúc mạc.

- Về già, cả chiều dài và đường kính âm đạo co lại, cổ tử cung nhô rất ít vào âm đạo, do đó các túi cùng âm đạo gần như biến đi.

Câu 12 . Hình thể trong, cấu tạo, ứng dụng lâm sàng của trực tràng

- Hình thể trong:
 - Bóng TT: niêm mạc nhô lên tạo nên 3 nếp ngang có hình lưỡi liềm cong còn gọi là van trực tràng: van trên, giữa, dưới
 - Ống HM: cao khoảng 38 mm, chia 3 phần từ trên xuống:
 - + Phần trên: cao 15mm, có những nếp dọc gọi là cột hậu môn, có từ 10-12 cột, rộng ở đầu dưới, hẹp ở đầu trên, mỗi cột chứa 1 đm, 1tm, nhiều bó cơ dọc
 - + Nếp niêm mạc nối chân các cột hậu môn với nhau gọi là các van hậu môn. Nghách nhỏ trên mỗi van là xoang hậu môn, các xoang sâu nh陷 ở thành sau có thể đọng phân và bị nhiễm trùng, gây áp xe thành ống hậu môn, van có thể bị rách do 1 cục phân rắn gây nứt hậu môn. Phần ống hậu môn nằm phía trên các van hậu môn gọi là vùng trĩ vì đám rối tĩnh mạch dưới niêm mạc ở đây khi bị ứ máu dễ phình, dẫn ra và khi vỡ sẽ gây xuất huyết
 - Đường vòng nối các van trực tràng là đường lược và đường nối đỉnh các cột là đường hậu môn trực tràng.
 - + Phần giữa =15mm (vùng chuyển tiếp) vì niêm mạc chuyển tiếp từ da (phần dưới) đến phần trên; được giới hạn: trên là đường lược, dưới là đường trắng (gian cơ).
 - + Phần dưới = 8mm, cấu tạo bởi da thực sự chứa nhiều tuyến bã, tuyến mồ hôi
 - Cấu tạo: 5 lớp từ ngoài vào trong: Thanh mạc, dưới thanh mạc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc, lớp niêm mạc
 - Thanh mạc: Do phúc mạc tạo nên. Phúc mạc không phủ hoàn toàn trực tràng. Mặt trước phủ từ trên xuống dưới đến $\frac{1}{3}$. Hai mặt bên phủ tới $\frac{1}{4}$. Đường bám của phúc mạc vào trực tràng có hình chữ U. Nét ngang ở mặt trước, nét thẳng ở 2 bên trực tràng.
 - Lớp dưới thanh mạc: sợi cơ trơn, MM, TK ôm 4 mặt trực tràng.
 - Lớp cơ: gồm 2 lớp cơ
 - + Lớp cơ dọc: nằm phía bên ngoài, không tập trung thành các dải cơ dọc như đại tràng
 - + Lớp cơ vòng nằm phía bên trong, liên tiếp với lớp cơ vòng đại tràng sigma, càng xuống dưới càng dày, phần dưới ống hậu môn có cơ thắt trong, cơ này dày 3-6 mm, cao khoảng 4-5 mm, nằm phía trong cơ thắt ngoài hậu môn. Cơ thắt vân hậu môn là một ống cơ vòng xung quanh ống hậu môn ở $\frac{2}{3}$ dưới. Cơ gồm 3 phần: phần dưới da, phần nông, phần sâu. Các sợi cơ quay xung quanh ống hậu môn, ở trước bám vào trung tâm gân đáy chậu, ở sau bám vào xương cụt và đường hậu môn cụt, một số sợi hoà cùng với lớp cơ dọc trực tràng, cơ nâng hậu môn. Cơ này tác dụng thắt chặt ống hậu môn một cách chủ động giữ phân không thoát ra ngoài
 - Lớp dưới niêm mạc : chứa nhiều mạch máu, thần kinh đặc biệt có đám rối TMTT
 - Lớp niêm mạc: Khác giữa 2 phần: ở bóng trực tràng là tế bào trụ đơn, ở ống hậu môn là tế bào trụ đơn ở phía trên và lát tầng ở dưới. Hệ thống tĩnh mạch phát triển. Lớp niêm mạc di động trên lớp cơ trơn
- UDLS:**
- Động mạch trực tràng trên là động mạch chính của trực tràng và tiếp nối với các nhánh động mạch trực tràng giữa và dưới. Tuy vậy vòng nối nhỏ không đủ cấp máu, nếu thắt toàn bộ trực tràng trên cần để lại nhánh nối với động mạch mạc treo tràng dưới
 - Có sự tiếp nối của hai hệ thống tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ ở niêm mạc trực tràng. Tĩnh mạch trực tràng trên thuộc hệ cửa trong lòng không có van, còn các tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới lại có van. Tuy vậy các van này hướng dòng máu chủ yếu về tĩnh mạch cửa. Vì vậy khi ung thư trực tràng có thể di căn gan và khi gan bị xơ các đám rối tĩnh mạch dẫn gây ra trĩ
 - Dòng bạch huyết nói chung là từ phía dưới đi lên là chính. Tuy vậy ung thư lan theo chiều cao trực tràng rất chậm, mà chủ yếu lan tới các tạng lân cận như tuyến tiền liệt hay âm đạo. Vì vậy, khi cắt ung thư trực tràng chỉ cần cắt trên khối u 4cm là đủ
 - Cắt bỏ trực tràng bệnh nhân hay bị choáng, nên cần đòi hỏi kỹ thuật cao và công tác theo dõi, chăm sóc chu đáo trước và sau mổ
 - Thăm dò trực tràng có thể dùng ống soi hay bằng tay, có thể thấy các khối u hay búi trực tràng. Ngoài ra, còn có thể thấy các tạng lân cận như tuyến tiền liệt, buồng trứng, túi cùng douglas.

Câu 13. Đáy chậu trước của nam, sự khác nhau giữa đáy chậu trước của nam và nữ. UDLS

Đáy chậu trước hay vùng niệu dục, có niệu đạo đi qua, ở nữ có thêm âm đạo đi qua, nên có khe hở niệu dục. Đáy chậu trước của nam và nữ khác nhau, song về cấu tạo từ nông vào sâu, ở cả hai giới đều bao gồm các lớp sau:

- Da, mô dưới da
 - Mạc đáy chậu nông
 - Khoang đáy chậu nông với các cơ: Cơ ngang đáy chậu nông, cơ ngồi hang và cơ hành xóp
 - Khoang đáy chậu sâu, trong khoang có 2 cơ: Cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt niệu đạo.
 - Đáy chậu trước của nam: chỉ có niệu đạo chọc qua
 - Da: Da phủ đáy chậu khá nhạy cảm, dọc theo đường giữa có đường đan đáy chậu.
 - Mạc đáy chậu nông: Mạc gồm 2 lớp
 - + Lớp mỡ ở nông, trong lớp này có các sợi cơ trơn mà liên tiếp phía sau với đáy chậu sau và phía trước với cơ trơn Dantos của bìu.
 - + Lớp mạc ở sâu: Bám vào bờ dưới ngành ngồi mu, phía trước liên tiếp với mạc bìu nông, phía sau vòng lên trên các tạng cương để bám vào bờ sau hoành niệu dục và bám vào gân trung tâm đáy chậu.
 - Khoang đáy chậu nông: Khoang này được giới hạn: Dưới là mạc đáy chậu nông, trên là màng đáy chậu (mạc dưới hoành niệu dục). Trong khoang có chứa các tạng cương (hai vật hang và vật xóp) và mỗi bên có 3 cơ đáy chậu nông:
 - + Cơ ngang đáy chậu nông. Nguyên uỷ: Từ ụ ngồi, mặt trong ngành ngồi. Bám tận: Gân trung tâm đáy chậu.
 - + Cơ ngồi hang: Nguyên uỷ: Từ mặt trong ngành xương ngồi. Bám tận: Các sợi cơ ôm xung quanh 3 mặt của vật hang, để bám tận vào mặt dưới vật hang. Vì vậy, khi cơ co sẽ ép vào vật hang.
 - + Cơ hành xóp: Nguyên uỷ: từ gân trung tâm đáy chậu và đường giữa. Đường đi và bám tận: Từ đường giữa, hai bên các sợi cơ đan chéo nhau, chạy vòng lên trên như một cái võng để cho phần đầu vật xóp nằm trên
- Các sợi đi lên bám tận vào mạc dưới hoành niệu dục. Một số sợi vòng lên trên ôm lấy gốc dương vật và hoa lẩn với các sợi bên đối diện.
- + Tóm lại: Các cơ trong khoang đáy chậu nông khi co sẽ ép vào gốc hai vật hang và vật xóp làm cho máu dồn ra trước, đồng thời làm cho máu tĩnh mạch của các tạng này không trở về được, trong khi đó máu động mạch vẫn được đưa tới. Kết quả làm cho hai vật hang và vật xóp cương to lên. Vì vậy, đây là các cơ làm cương và duy trì sự cương dương vật.
- Thần kinh chi phối cho các cơ này là nhánh của thần kinh thẹn và động mạch nuôi dưỡng là nhánh của động mạch thẹn trong.
- Khoang đáy chậu sâu: Khoang này được giới hạn: Trên là mạc trên hoành niệu dục. Dưới là mạc dưới hoành niệu dục (màng đáy chậu). Trong khoang, ở mỗi bên có 2 cơ là: Cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt ngoài niệu đạo.
 - + Cơ ngang đáy chậu sâu. Nguyên uỷ: Bám vào mặt trong xương ngồi, phía trên chỗ bám của cơ ngang đáy chậu nông. Đường đi và bám tận: Đường giữa và trung tâm gân đáy chậu. Nằm trong bề dày của cơ này, có tuyến hành niệu đạo.
 - + Cơ thắt ngoài niệu đạo: Nguyên uỷ: Bám vào mặt trong ngành dưới xương mu. Đường đi và bám tận: Các sợi chạy từ ngoài vào trong ôm xung quanh niệu đạo, và đan với các sợi cơ bên đối diện tạo nên một cơ thắt quanh niệu đạo.
 - Sự khác biệt đáy chậu nam và nữ
- Vì nữ có âm đạo đi qua, nên đáy chậu trước của nữ và nam có một số sự khác biệt về cấu trúc, nhất là về cơ. Các mạc, mạch máu và thần kinh cũng giống như ở nam giới.
- Khoang đáy chậu nông: Các tạng cương nói chung nhỏ hơn ở nam giới. Hành xóp và cơ hành xóp bị tách đôi bởi âm đạo.
 - + Cơ ngang đáy chậu nông nhỏ hơn, kém phát triển hơn
 - + Cơ hành xóp của nữ bị tách làm đôi, vòng quanh lỗ âm đạo và phủ lên phần bên hành tiền đình..
 - + Cơ ngồi hang: nhỏ hơn ở nam giới, che phủ trụ của âm vật

- Khoang đáy chậu sâu:

+ Màng đáy chậu của nữ kém phát triển hơn so với nam giới vì bị chia đôi bởi âm đạo.

+ Cơ thắt niệu đạo ở nữ không có chức năng như một cơ thắt thực sự, khả năng thắt yếu hơn nam

• Áp dụng lâm sàng

Hiểu rõ các lớp cấu trúc đáy chậu ở nữ giới giúp ứng dụng trong một số chuyên ngành như:

- Phẫu thuật tạo hình âm đạo trong thẩm mỹ và một số bệnh lý.

- Giúp hiểu rõ về cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và các phẫu thuật điều trị sa tạng niệu dục ở nữ

Câu 14. Đáy chậu trước của nữ, sự khác nhau đáy chậu trước của nam và nữ. UDLS

Đáy chậu trước hay vùng niệu dục, có niệu đạo đi qua, ở nữ có thêm âm đạo đi qua, nên có khe hở niệu dục. Đáy chậu trước của nam và nữ khác nhau, song về cấu tạo từ nông vào sâu, ở cả hai giới đều bao gồm các lớp sau:

- Da, mô dưới da
- Mạc đáy chậu nông
- Khoang đáy chậu nông với các cơ: Cơ ngang đáy chậu nông, cơ ngồi hang và cơ hành xóp
- Khoang đáy chậu sâu, trong khoang có 2 cơ: Cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt niệu đạo.

* Đáy chậu trước của nữ

- Da: Da phủ đáy chậu khá nhạy cảm, dọc theo đường giữa có đường đan đáy chậu
- Mạc đáy chậu nông:
 - + Lớp mỡ ở nông, trong lớp này có các sợi cơ trơn mà liên tiếp phía sau với đáy chậu sau.
 - + Lớp mạc ở sâu: Bám vào bờ dưới ngành ngồi mu, phía trước liên tiếp với mạc bì nông, phía sau vòng lên trên các tạng cương để bám vào bờ sau hoành niệu dục và bám vào trung tâm gân đáy chậu.

- Khoang đáy chậu nông: Khoang này được giới hạn bởi: Phía dưới là mạc đáy chậu nông, phía trên là màng đáy chậu (mạc dưới hoành niệu dục). Trong khoang có chứa các tạng cương và mỗi bên có 3 cơ đáy chậu nông là: Cơ ngang đáy chậu nông; Cơ ngồi hang; Cơ hành xóp. Hành xóp và cơ cơ hành xóp bị tách làm đôi bởi phần dưới âm đạo.

Nguyên ủy Đường đi & bám tận Động tác

Cơ hành xóp (Bị tách đôi thành 2 cơ phải và trái) Trung tâm gân đáy chậu và đường giữa

Từ nguyên ủy, hai cơ chạy ra trước vòng quanh phần dưới âm đạo và bao quanh hành tiền đình, tuyến hành tiền đình lớn (tuyến bartholin) để bám tận vào xương mu và lưng âm vật.

- Ép âm đạo làm khít âm đạo

- Ép tuyến bartholin làm tiết dịch nhờn vào tiền đình âm hộ

Cơ ngồi hang Mặt trong ngành xương ngồi Bám vào các bên của mặt dưới trụ âm vật

Ép vào trụ âm vật, làm cương âm vật

Cơ ngang đáy chậu nông Ụ ngồi, mặt trong ngành ngồi Gân trung tâm đáy chậu

Thần kinh chi phối cho các cơ này là nhánh của thần kinh thẹn và động mạch nuôi dưỡng là nhánh của ĐM thẹn trong.

- Khoang đáy chậu sâu: Khoang này được giới hạn bởi: Phía trên là mạc trên hoành niệu dục, phía dưới là mạc dưới hoành niệu dục (màng đáy chậu). Trong khoang, mỗi bên có 2 cơ là: Cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt ngoài niệu đạo

Nguyên ủy Đường đi & Bám tận Động tác

Cơ ngang đáy chậu sâu Mặt trong xương ngồi (trên chỗ bám của cơ ngang đáy chậu nông) -

Các sợi phía sau bám vào trung tâm gân đáy chậu

- Các sợi phía trước bám vào thành bên âm đạo Giúp cố định trung tâm gân đáy chậu

Cơ thắt niệu đạo Mặt trong ngành dưới xương mu Đa số các sợi bám vào thành bên âm đạo, chỉ một ít sợi đi ra trước bám vào niệu đạo và đi giữa niệu đạo – âm đạo. Không có khả năng như một cơ thắt thực sự (yếu hơn nam giới)

Che phủ phía trên 2 cơ này là mạc trên hoành niệu dục, mạc này mỏng. Còn che phủ mặt dưới hai cơ này là mạc dưới hoành niệu dục, mạc này dày và chắc, có tạng cương dính vào nên còn gọi là mảnh treo các tạng cương. Phía sau của 2 mạc này dính vào nhau và cùng dính vào mạc đáy chậu nông và trung tâm gân đáy chậu. Phía trước 2 mạc này hòa lẫn vào nhau và tạo thành dây chằng ngang.

• Sự khác biệt đáy chậu nam và nữ

Vì nữ có âm đạo đi qua, nên đáy chậu trước của nữ và nam có một số sự khác biệt về cấu trúc, nhất là về cơ. Các mạc, mạch máu và thần kinh cũng giống như ở nam giới.

- Khoang đáy chậu nông: Các tạng cương nói chung nhỏ hơn ở nam giới. Hành xóp và cơ hành xóp bị tách đôi bởi âm đạo.

+ Cơ ngang đáy chậu nông nhỏ hơn, kém phát triển hơn

+ Cơ hành xấp của nữ bị tách làm đôi, vòng quanh lỗ âm đạo và phủ lên phần bên hành tiền đình..

+ Cơ ngồi hang: nhỏ hơn ở nam giới, che phủ trụ của âm vật

- Khoang đáy chậu sâu:

+ Màng đáy chậu của nữ kém phát triển hơn so với nam giới vì bị chia đôi bởi âm đạo.

+ Cơ thắt niệu đạo ở nữ không có chức năng như một cơ thắt thực sự, khả năng thắt yếu hơn nam giới.

• Áp dụng lâm sàng: hiểu rõ các lớp cấu trúc đáy chậu ở nữ giới giúp ứng dụng trong một số chuyên ngành như:

- Khâu tầng sinh môn trong đẻ thường, đặc biệtj các trường hợp rách phức tạp.

- Phẫu thuật tạo hình âm đạo trong thâm mỹ và và một số bệnh lý.

- Giúp hiểu rõ về cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán và các phẫu thuật điều trị sa tạng niệu dục ở nữ

Câu 15. Vị trí, hình thể, liên quan của bàng quang và UDLS

Bàng quang là một túi chứa nước tiểu, nước tiểu từ thận qua 2 niệu quản xuống bàng quang, rồi được thải ra ngoài qua niệu đạo. bàng quang có vị trí hình thể, kích thước thay đổi theo lượng nước tiểu chứa trong nó, ngoài ra còn thay đổi theo tuổi.

- **Vị trí, dung tích:**

Vị trí: khi rỗng, bàng quang ở người trưởng thành là một tạng nằm dưới phúc mạc, trong chậu hông bé, sau x mu, trước các tạng sinh dục - trực tràng và ở trên hoành chậu. Khi bàng quang đầy, nó vượt quá bờ trên xương mu, nằm sau thành bụng trước, các bờ tròn lại và biến mất, trở thành hình trứng, vượt trên khớp mu khoảng 5cm, khi căng quá có thể lên tới rốn, thậm chí cao hơn nữa. Bàng quang ở trẻ mới sinh nằm sau thành bụng trước, kéo dài từ rốn tới hoành chậu như quả bầu, khi lớn lên, bàng quang tụt dần xuống vùng chậu; phần ống niệu rốn hẹp dần và bít hẳn tạo thành dây chằng rốn giữa. Và chỉ tới tuổi sau dậy thì bàng quang mới hoàn toàn nằm trong chậu hông. Ở người già, do trương lực cơ thành bụng yếu, bàng quang có hơi nhô lên trên về phía bụng.

Dung tích bàng quang rất thay đổi, bình thường khi bàng quang chứa khoảng 250- 300ml nước tiểu thì cảm giác muốn đi tiểu. Trong những trường hợp bí tiểu, bàng quang có thể chứa tới 3 lít.

- **Hình thể ngoài và liên quan:**

Ở người trưởng thành, như 1 hình tháp tam giác, bàng quang gồm: 1 đỉnh, một đáy, một cổ, một mặt trên và 2 mặt dưới bên. Phần chính được giới hạn bởi 4 mặt trên gọi là thân bàng quang.

- **Mặt trên:**

Được che phủ bởi phúc mạc, lồi khi bàng quang đầy và lõm khi bàng quang rỗng, làm cho lòng bàng quang có hình chữ Y hay chữ T trên thiết đồ cắt đứng dọc. Mặt này có liên quan:

- + **Liên quan với phúc mạc:**

Ở trước và bên, sau khi phúc mạc phủ mặt trên bàng quang rồi lật lên phủ mặt sau thành bụng trước, thành bên chậu hông. Khi bàng quang đầy, mặt chằng mu- bàng quang vào bàng quang, còn hai cạnh là thừng động mạch

- + Hai tĩnh mạch trước bàng quang là mốc quan trọng để nhận định bàng quang (phân biệt bàng quang với các quai ruột, khi bàng quang rỗng).

- **Mặt sau dưới hay đáy bàng quang:**

- + Với phúc mạc: ở nữ phúc mạc không phủ mặt này mà chỉ tới bờ sau của mặt trên thì lật lên phủ mặt trước - dưới tử cung. Ở nam, phúc mạc lách giữa bàng quang và túi tinh, ống tinh, tạo nên túi bịt bàng quang - sinh dục, rồi lại lách giữa túi tinh và trực tràng, tạo nên túi bịt sinh dục - trực tràng hay túi Douglas. Túi bịt trên không được rõ lắm, còn túi Douglas xuống sâu nhất trong chậu hông bé.

- + Với các tạng, khác nhau giữa nam và nữ: Ở nam, bàng quang liên quan với bóng túi tinh và ống dẫn tinh. Hai túi tinh tùm ở đầu dưới và tạo nên một tam giác (tam giác liên túi tinh). Trong tam giác có hai ống dẫn tinh, chúng cũng tách nhau ở trên và tùm ở dưới, nên lại có một tam giác (tam giác liên ống tinh). Tam giác này lồng trong tam giác trên. Niệu quản lách giữa bàng quang và túi tinh. Qua túi tinh, ống dẫn tinh, bàng quang liên quan với trực tràng. Ở nữ, 1/3 trên liên quan với cổ tử cung, 2/3 dưới liên quan với thành trước âm đạo. Bàng quang dính với các tạng này qua tổ chức liên kết lỏng lẻo. Vì vậy, trong trường hợp đẻ khó, có thể gây rách âm đạo - bàng quang.

- **Đỉnh bàng quang:** hướng ra trước và lên trên, về phía trên khớp mu. Là nơi gặp nhau giữa 2 mặt dưới bên và mặt trên của bàng quang ở phía trước. Đây là nơi bám của dây treo bàng quang (dây chằng rốn giữa). Đỉnh là nơi cao nhất bàng quang khi bàng quang rỗng. Còn khi bàng quang căng, nơi cao nhất bàng quang là một điểm ở mặt trên bàng quang.

- **Cổ bàng quang:** Là nơi thấp nhất của bàng quang - nơi gặp nhau của đáy và mặt dưới - bên của bàng quang, là nơi cố định nhất. Cổ nằm ngang giữa xương mu, cách xương mu khoảng 3cm. Phía trong của cổ, bàng quang mở vào niệu đạo bởi một lỗ gọi là lỗ niệu đạo trong. Ở nam, cổ bàng quang đè lên đáy tuyến tiền liệt, còn ở nữ, cổ bàng quang nằm trên mạc chậu bao quanh phần trên niệu đạo.

- **Các mặt dưới bên:**

- + Ở phía trước được ngăn cách với xương mu bởi 1 khoang sau mu (khoang Retzius), chứa đựng một khối liên kết mỡ nhão là mỡ sau mu

+ Ở 2 bên xa hơn về phía sau được ngăn cách với cơ nâng hậu môn và cơ bịt trong bởi mạc hoành chậu trên

UDLS:

- Bàng quang căng dễ bị vỡ, do chấn thương nửa dưới thành bụng trước hoặc do vỡ xương chậu. Vỡ bàng quang có thể ở ngoài phúc mạc, hoặc trong phúc mạc, nếu vỡ ở mặt trên làm rách phúc mạc.
- Nếu tắc đường tháo nước tiểu lâu ngày, chẳng hạn do u xơ tuyến tiền liệt hay hẹp niệu đạo, bàng quang trở lên căng và phì đại lớp cơ, các bó cơ tăng kích thước và đan chéo mọi chiều gây lên hiện tượng bàng quang bị kéo bè (trabeculated bladder).
- Khi bàng quang bị ứ tắc, sau khi đi tiểu, nước tiểu không thoát ra hoàn toàn được, lượng nước tiểu đọng lại sau khi đái có thể gây lên nhiễm trùng; và nhiễm trùng có thể lan theo niệu quản lên thận. Áp lực ngược dòng từ bàng quang, do bàng quang bị căng có thể gây nên giãn niệu quản, bể thận và cả các ống góp ở trong thận.
- Khi bó thon bị tổn thương ở tủy sống, sẽ gây nên mất cảm giác căng và buồn đi tiểu. Trong những tổn thương nặng tủy sống ở đoạn tủy cùng, các dải thần kinh đi lên hay xuống điều khiển sự tháo đái bị cắt đứt, dẫn tới hiện tượng đái dầm dề.
- Có thể thăm khám bàng quang khi soi bàng quang, bằng cách đưa ống soi qua đường niệu đạo. Cũng có thể luồn ống soi vào niệu quản để thăm khám niệu quản hay lấy mẫu nước tiểu riêng từ mỗi thận, hoặc bơm thuốc cản quang vào niệu quản và bể thận để chụp thận ngược dòng.
- Người ta có thể chọc dò, hoặc mở bàng quang trên mu mà không gây tổn thương phúc mạc. Khi bàng quang chứa 300ml nước, mặt trước - dưới của nó nằm áp trực tiếp với thành bụng trước không qua phúc mạc và nằm cao hơn khớp mu khoảng 7,5cm. Có thể mở bàng quang qua đường này để lấy sỏi. Ở nữ, do niệu đạo ngắn và dễ giãn, nên có thể lấy sỏi nhỏ qua niệu đạo.